GUÍA PSICOEDUCATIVA – NOVIEMBRE 2026

Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I)

Guía clínica y psicoeducativa con herramientas basadas en evidencia para restablecer la calidad del descanso.

Tratamiento de primera línea · AASM

JF

Lic. Jésica Verónica Favara · MN 58746

www.jesicafavara.com.ar – Noviembre 2026

Qué encontrará en esta guía

Marco psicoeducativo y terapéutico basado en la TCC-I, el tratamiento de primera línea recomendado por la American Academy of Sleep Medicine (AASM).

03–04 Fundamentos del sueño y mitos

05–08 Trastornos y estudios diagnósticos

09–10 Horas de sueño y consecuencias

11 Autoevaluación orientativa

12–15 Técnicas de la TCC-I

16–17 Diario y registro nocturno

18–19 Referencias y cierre

Objetivos del tratamiento TCC-I

1. Reducir el tiempo que se tarda en dormirse y los despertares nocturnos.
2. Aumentar la eficiencia del sueño y la sensación de descanso.
3. Modificar los hábitos y las creencias que mantienen el insomnio.
4. Disminuir la hiperactivación física y mental a la hora de dormir.

Cómo se regula el sueño

Modelo de dos procesos de Borbély (1982): dos sistemas biológicos que interactúan.

S

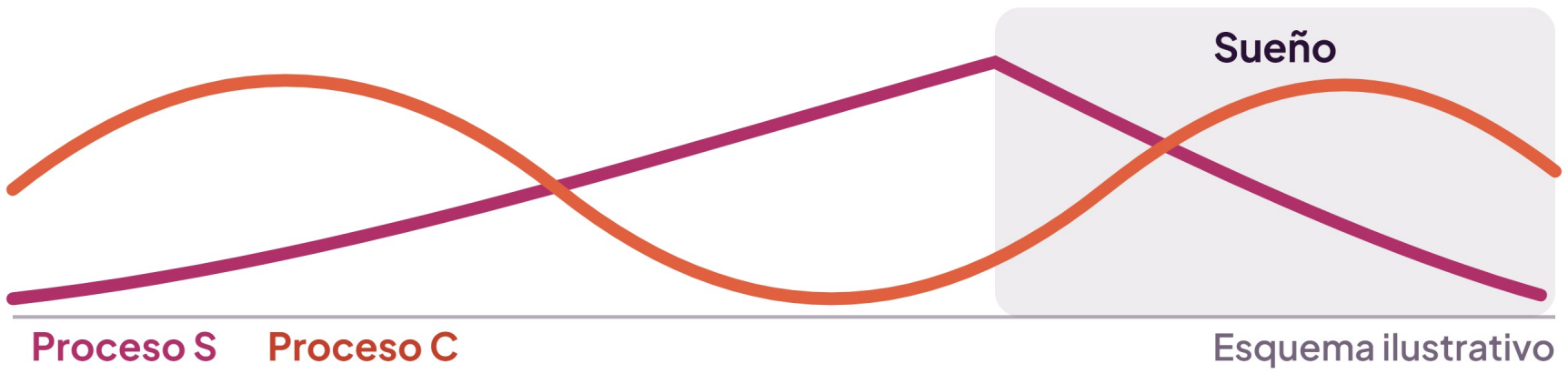
Proceso S · Homeostático

Es la «presión de sueño». Aumenta progresivamente mientras estamos despiertos por la acumulación de adenosina en el prosencéfalo basal. Al dormir, la adenosina se degrada y la presión se disipa.

C

Proceso C · Circadiano

Reloj biológico interno de ~24 horas, regulado por el núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo. Responde a señales ambientales (zeitgebers), sobre todo la luz solar: impulsa el cortisol por la mañana y la melatonina por la noche.



3 mitos sobre el sueño

Lo que se cree frente a lo que muestra la evidencia.

MITO

«Todos debemos dormir exactamente 8 horas continuas.»

EVIDENCIA

La necesidad de sueño varía según la genética, la edad y el estado fisiológico. Importa más la calidad estructural (fases NREM y REM) que una cifra exacta de horas.

MITO

«Recuperar el sueño perdido el fin de semana elimina el cansancio.»

EVIDENCIA

Cambiar los horarios genera «jet lag social»: desplaza la fase del Proceso C y perpetúa la desregulación circadiana.

MITO

«Una copa antes de acostarme me ayuda a dormir mejor.»

EVIDENCIA

El alcohol altera la arquitectura del sueño: fragmenta la segunda mitad de la noche y suprime el sueño REM.

Trastornos del sueño

Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, 3.ª edición (ICSD-3).

INSOMNIO

Trastorno de insomnio crónico

Dificultad persistente para iniciar, mantener o consolidar el sueño, al menos 3 veces por semana durante 3 meses o más, con disfunción diurna.

RESPIRATORIO

Apnea obstructiva del sueño (AOS)

Colapso repetido de la vía aérea superior durante el descanso: produce hipoxias transitorias y microdespertares.

CIRCADIANO

Trastornos del ritmo circadiano

Desalineación entre el patrón endógeno y las demandas del entorno (p. ej., fase retrasada o adelantada del sueño).

PARASOMNIAS

Conductas anormales al dormir

Sonambulismo, terrores nocturnos y trastorno de conducta del sueño REM, entre otras.

Ante sospecha de apneas, somnolencia intensa o síntomas persistentes, consulte con un especialista en medicina del sueño.

Parálisis del sueño

Parasomnia transitoria que ocurre en la transición entre el sueño REM y la vigilia (también puede darse al comenzar a dormir).

1

Atonía REM

Durante el sueño REM, el tronco encefálico inhibe las motoneuronas espinales mediante GABA y glicina, para que no ejecutemos físicamente lo que soñamos.

2

El fenómeno

La persona recupera la conciencia y el estado de alerta mientras la atonía muscular todavía continúa: está despierta, pero no puede moverse ni hablar.

3

Alucinaciones

Pueden aparecer alucinaciones hipnagógicas (al dormirse) o hipnopómpicas (al despertar), por la intrusión de imaginería REM en la vigilia.

Es benigna, y tiene explicación

No genera daño orgánico y suele durar de segundos a pocos minutos. La favorecen la privación de sueño, los horarios irregulares y el estrés. Si es muy frecuente o genera malestar, consulte.

Estudios del sueño

Cuando las alteraciones del descanso son persistentes o se sospecha un origen orgánico, se recurre a estudios validados.

Polisomnografía nocturna (PSG)

GOLD STANDARD

Registra durante toda la noche EEG, EOG, EMG, ECG, flujo aéreo y oximetría. Permite diagnosticar con precisión apneas obstructivas, movimientos periódicos de piernas y alteraciones en las fases N1, N2, N3 y REM.

Actigrafía

1–2 SEMANAS

Dispositivo similar a un reloj que mide movimiento y luz. Estima de forma objetiva los patrones reales de sueño y vigilia y los ritmos circadianos en el ambiente natural de la persona.

Test de latencias múltiples (TLMS)

4–5 SIESTAS

Mide qué tan rápido se queda dormida la persona en varias oportunidades de siesta durante el día. Evalúa la somnolencia diurna excesiva y orienta el diagnóstico de narcolepsia.

Qué más afecta el sueño

Endocrinos y metabólicos

Hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes mellitus y cambios hormonales (p. ej., menopausia).

Dolor crónico y reumatológicos

Fibromialgia, artritis reumatoidea y dolor neuropático: causan microdespertares por dolor.

Cardiovasculares y respiratorios

Insuficiencia cardíaca, EPOC y asma nocturna.

Neurológicos

Parkinson, demencias, migraña y neuropatías periféricas.

Sustancias y fármacos

Cafeína: antagoniza los receptores de adenosina. **Nicotina:** es un estimulante.

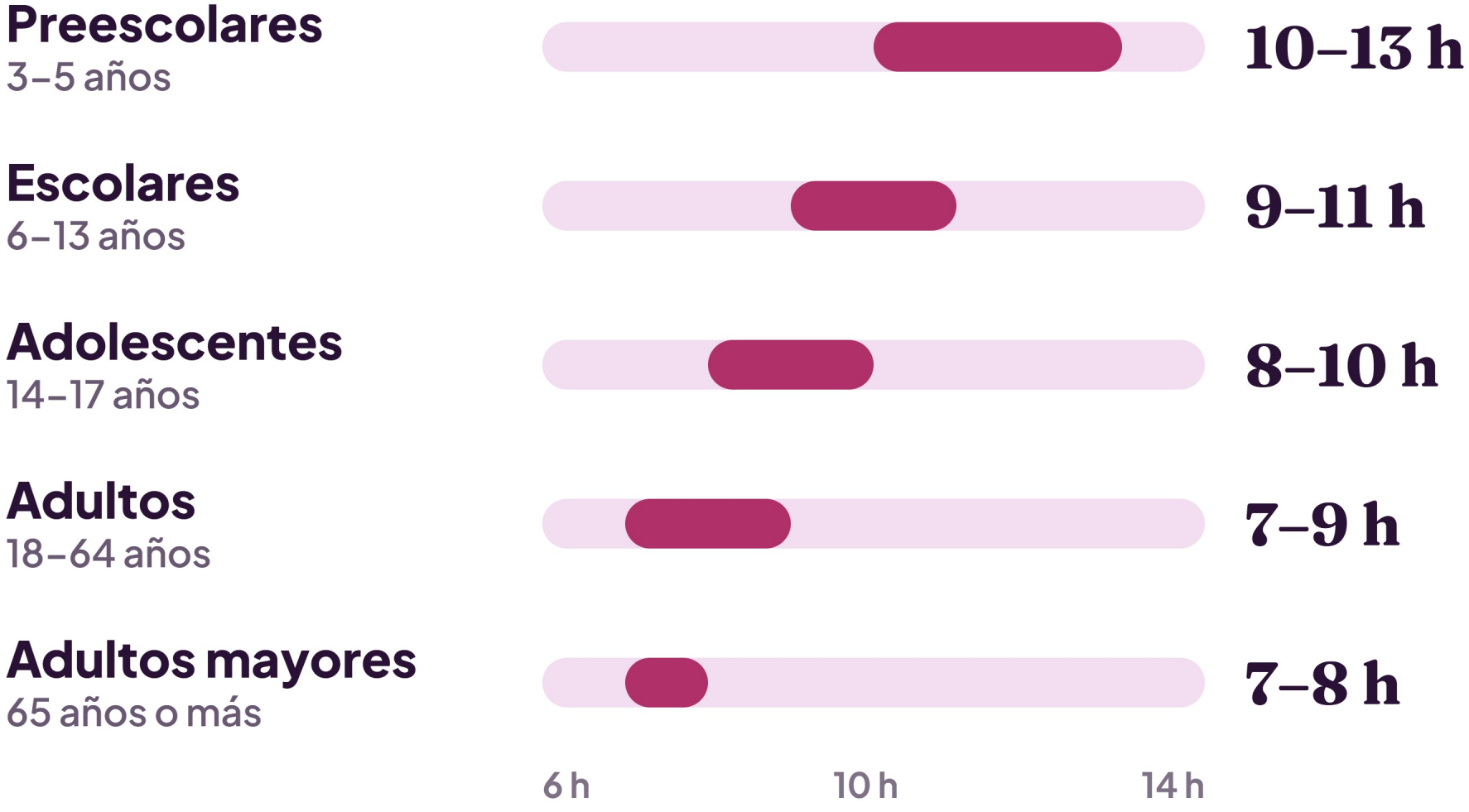
Alcohol: fragmenta la segunda mitad de la noche y suprime el sueño REM.

Medicamentos: betabloqueantes, corticoides, descongestivos con pseudoefedrina y algunos antidepresivos pueden aumentar la alerta o la frecuencia cardíaca.

No suspenda ni modifique ningún medicamento sin consultar a su médico.

Cuántas horas necesitamos

Rangos recomendados por la National Sleep Foundation (Hirshkowitz et al., 2015).



La necesidad es individual

Depende de la genética, la edad y el estado fisiológico. Si duerme dentro de su rango y se siente descansado durante el día, su patrón es funcional.

Privación crónica de sueño

Dormir poco de forma sostenida afecta a todo el organismo.

MENTE

Área neurocognitiva

Menor atención sostenida, fallas en la consolidación de la memoria y descenso del procesamiento ejecutivo.

EMOCIONES

Área emocional y psiquiátrica

Mayor reactividad de la amígdala y mayor vulnerabilidad a episodios depresivos y cuadros de ansiedad.

CUERPO

Área inmunológica y metabólica

Debilita la respuesta inmune, altera las hormonas del apetito (↑ grelina, ↓ leptina) y aumenta el riesgo cardiovascular y la resistencia a la insulina.

¿Cómo está su sueño?

Considere las últimas dos semanas. Sume los puntos. Es un instrumento orientativo, no diagnóstico.

1 ¿Cuánto tarda en conciliar el sueño una vez que apaga la luz?

Menos de 20 min **0 pts**	20 a 45 min **1 pt**	Más de 45 min **2 pts**

2 ¿Cuántas veces se despierta durante la noche?

0 a 1 vez **0 pts**	2 a 3 veces **1 pt**	4 veces o más **2 pts**

3 ¿Cómo evalúa su descanso al despertar?

Reparador **0 pts**	Algo cansado **1 pt**	Muy agotado **2 pts**

4 ¿La preocupación por no dormir aumenta al acercarse la noche?

Nunca **0 pts**	A veces **1 pt**	Casi siempre **2 pts**

5 ¿Con qué frecuencia el cansancio interfiere con su día?

Rara vez **0 pts**	2–3 días/semana **1 pt**	Casi todos los días **2 pts**

0 a 3 puntos: patrón dentro de parámetros funcionales.

4 a 6 puntos: alteración moderada o higiene del sueño desregulada.

7 a 10 puntos: indicadores que sugieren insomnio. Se recomienda una evaluación profesional.

Control de estímulos

Terapia de control de estímulos (Bootzin, 1972).

¿Por qué funciona?

El insomnio genera una asociación aprendida (condicionamiento clásico e instrumental) entre la cama y la activación: ansiedad, rumiación, frustración. La técnica reasocia la cama con dormir.

1. Use la cama solo para dormir y para la actividad sexual.
2. Si no se duerme en unos 15–20 minutos, levántese de la cama.
3. Pase a otra habitación con luz tenue y haga algo tranquilo y monótono (p. ej., leer un libro impreso).
4. Vuelva a la cama solo cuando sienta somnolencia clara.
5. Levántese siempre a la misma hora, sin importar cuánto durmió.

Restricción del sueño

Restricción y compresión del sueño (Spielman et al., 1987).

¿Por qué funciona?

Limita el tiempo en cama al tiempo real de sueño. Así aumenta la presión homeostática (Proceso S), se consolida el descanso y se reducen los microdespertares. La compresión es la versión gradual: se reduce el tiempo en cama de a poco.

1. Con el diario de sueño, calcule cuánto duerme realmente (promedio de 7 a 14 días). Limite el tiempo en cama a ese valor, nunca menos de 5 horas, con hora fija de levantarse.

2. Cada semana calcule la eficiencia: (tiempo dormido ÷ tiempo en cama) × 100.

3. Ajuste el horario según el resultado:

90 % o más	85 a 89 %	menos de 85 %
+15 min	mantener	−15 min

Hágalo con guía profesional

Puede aumentar la somnolencia diurna: precaución al conducir. Requiere cautela en trastorno bipolar, epilepsia, parasomnias y apnea sin tratar. Los umbrales pueden variar según el protocolo.

Calmar mente y cuerpo

Reestructuración cognitiva y desactivación fisiológica. Los pensamientos catastróficos sobre no dormir elevan la hiperactivación y bloquean el inicio del sueño (Morin, 1993).

PENSAMIENTO DISFUNCIONAL

«Si no duermo 8 horas exactas hoy, mañana no podré rendir en mi trabajo y me voy a enfermar.»

REENCUADRE

«Mi cuerpo tiene mecanismos de compensación. Ya funcioné antes con menos descanso y mañana puedo completar lo principal adaptando el ritmo.»

Para bajar la activación

Descarga cognitiva (brain dump)

Antes de acostarse, anote en una libreta los pendientes del día siguiente: descargar la mente de tareas abiertas ayuda a reducir la rumiación y la carga de la memoria de trabajo.

Respiración diafragmática

Disminuye el tono simpático e incrementa la modulación parasimpática vagal.

Relajación muscular progresiva (Jacobson)

Tensar y soltar grupos musculares en secuencia reduce la activación fisiológica.

Higiene del sueño

Tres moduladores del ambiente y del cuerpo, con respaldo en la evidencia.

Luz y pantallas 60–90 min

La luz azul (460–480 nm) de pantallas y LED suprime la melatonina a través de las células ganglionares fotosensibles de la retina. Suspenda las pantallas 60 a 90 minutos antes de acostarse.

Temperatura 18–21 °C

Para dormirse, la temperatura corporal central debe descender aproximadamente 1 °C. Mantenga el dormitorio fresco y tome una ducha tibia 1–2 horas antes: favorece la vasodilatación periférica.

Ruido, oscuridad y confort

Use ruido blanco si hay sonidos impredecibles. Procure oscuridad total o utilice un antifaz. Cuide el confort del colchón y la almohada.

Y además

Regule la cafeína y la nicotina, evite el alcohol como «ayuda» para dormir, haga ejercicio de forma regular (no muy cerca de la hora de dormir) y busque luz natural por la mañana.

Mi diario de sueño

Complételo cada mañana, apenas se despierta. Con estos datos se calcula la eficiencia del sueño y se ajusta el tratamiento.

Día	Hora de ir a la cama	Tiempo hasta dormirse	Despertares nocturnos	Hora de despertar	Tiempo total dormido	Calidad (1–5)
Lunes						
Martes						
Miércoles						
Jueves						
Viernes						
Sábado						
Domingo						

Eficiencia = (tiempo total dormido ÷ tiempo total en cama) × 100

Ejemplo: 6 h dormidas en 8 h en cama = 75 %.

Observaciones: anote el consumo de cafeína o alcohol, el ejercicio y los eventos estresantes del día.

Registro de experiencias nocturnas

Úselo solo si tiene pesadillas recurrentes, parálisis del sueño o despertares con mucha activación emocional.

Fecha

Hora del evento

Descripción (pesadilla, parálisis del sueño o despertar abrupto)

Pensamientos al despertar

Malestar emocional (1 = nulo, 10 = máximo)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sensaciones corporales

Estrategia aplicada (reestructuración, respiración diafragmática, orientación a la realidad)

Nota terapéutica: ante pesadillas recurrentes asociadas a trauma, se recomienda la Terapia de Ensayo en Imaginería (IRT, por sus siglas en inglés), aplicada con un profesional.

Referencias

American Academy of Sleep Medicine. (2014). *International classification of sleep disorders* (3.ª ed.). American Academy of Sleep Medicine.

Bootzin, R. R. (1972). Stimulus control treatment for insomnia. *Proceedings of the 80th Annual Convention of the American Psychological Association, 7*, 395–396.

Borbély, A. A. (1982). A two-process model of sleep regulation. *Human Neurobiology, 1*(3), 195–204.

Edinger, J. D., Arnedt, J. T., Bertisch, S. M., Carney, C. E., Harrington, J. J., Lichstein, K. L., Sateia, M. J., Troxel, W. M., Zhou, E. S., Kazmi, U., Heald, J. L., & Martin, J. L. (2021). Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: An American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *Journal of Clinical Sleep Medicine, 17*(2), 255–262. https://doi.org/10.5664/jcsm.8986

Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S. M., Alessi, C., Bruni, O., DonCarlos, L., Hazen, N., Herman, J., Katz, E. S., Kheirandish-Gozal, L., Neubauer, D. N., O'Donnell, A. E., Ohayon, M., Peever, J., Rawding, R., Sachdeva, R. C., Setters, B., Vitiello, M. V., Ware, J. C., & Adams Hillard, P. J. (2015). National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: Methodology and results summary. *Sleep Health, 1*(1), 40–43. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.010

Morgenthaler, T. I., Auerbach, S., Casey, K. R., Kristo, D., Maganti, R., Ramar, K., Zak, R., & Kartje, R. (2018). Position paper for the treatment of nightmare disorder in adults: An American Academy of Sleep Medicine position paper. *Journal of Clinical Sleep Medicine, 14*(6), 1041–1055. https://doi.org/10.5664/jcsm.7178

Morin, C. M. (1993). *Insomnia: Psychological assessment and management*. Guilford Press.

Morin, C. M., Stone, J., Trinkle, D., Mercer, J., & Remsberg, S. (1993). Dysfunctional beliefs and attitudes about sleep among older adults with and without insomnia complaints. *Psychology and Aging, 8*(3), 463–467. https://doi.org/10.1037/0882-7974.8.3.463

Spielman, A. J., Saskin, P., & Thorpy, M. J. (1987). Treatment of chronic insomnia by restriction of time in bed. *Sleep, 10*(1), 45–56. https://doi.org/10.1093/sleep/10.1.45

Dormir mejor se puede aprender

La TCC-I es el tratamiento de primera línea para el insomnio crónico. Si esta guía le resultó útil, compártala con quien pueda necesitarla.

Sobre la autora:

JF

Jésica V. Favara es Licenciada en Psicología, Profesora de Enseñanza Media y Superior en Psicología y Magíster en Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente cursa su Doctorado en Psicología. Se desempeña como docente universitaria e investigadora científica. Su enfoque integra la práctica clínica basada en la evidencia (TCC, DBT, ACT, EMDR) con una sólida formación pedagógica, pensada para diseñar herramientas claras y accesibles que faciliten el aprendizaje y la regulación emocional de los pacientes.

Más info en www.jesicafavara.com.ar

AVISO IMPORTANTE

Esta guía tiene fines exclusivamente psicoeducativos y orientativos. No sustituye la consulta psiquiátrica, médica ni psicológica individualizada. Ante apneas, somnolencia severa o trastornos persistentes, consulte con un profesional especialista en medicina del sueño.